

남성의 복압성 요실금(SUI)이란 기침, 일어서기, 물건 들기 또는 활동 중 방광에 갑자기 압력이 가해질 때 소변이 새는 상태를 말합니다. 남성에서는 거의 대부분 전립선 수술이나 방사선 치료 후 요도괄약근(소변을 참는 밸브 근육)이 약해져서 발생합니다. 첫 1년 동안 자연적으로 호전되는 경우가 많으며, 호전되지 않을 때는 매우 효과적인 치료법이 있습니다.

이 질환에 대하여

전립선을 제거하면 **요도괄약근**(소변을 참는 밸브)이 혼자 역할을 담당해야 하며, 이 근육이 약해질 수 있습니다. 그 결과 힘을 줄 때 소변이 새어 나오는데, 패드가 필요한 수준의 몇 방울에서 심한 누출까지 다양합니다. 이는 갑자기 요의를 느끼는 **절박성** 요실금과는 다르며 치료법도 다릅니다. 두 가지를 모두 가진 분도 있습니다.

원인

- **근치적 전립선 절제술**(암으로 인한 전립선 제거) — 가장 흔한 원인
- 기타 전립선 시술 또는 **골반 방사선 치료**
- 드물게 신경 또는 방광 문제

요실금은 **수술 직후 가장 심하며**, 수주~수개월 동안 치유와 골반저근 회복이 진행되면서 점차 좋아집니다.

용어 설명

복압성 요실금

기침, 일어서기, 물건 들기 등 압력이 가해질 때 소변이 새는 상태.

괄약근

소변을 참을 수 있게 해주는 근육 밸브.

전립선 절제술

전립선을 제거하는 수술로, 남성 복압성 요실금의 주요 원인.

골반저

소변을 조절하도록 훈련하는 근육 부위.

패드 검사

하루 패드 사용 개수로 요실금 정도를 측정하는 방법.

남성 슬링

경증~중등도 요실금을 위해 요도 아래에 거치하는 지지대.

ProACT 풍선

요도 옆에 삽입하는 조절 가능한 두 개의 소형 풍선으로, 외래에서 조정하는 최소침습 선택지.

인공 요도괄약근

중등도~중증 요실금을 위한 이식형 기기(AUS); 본인이 조작하는 커프.

좋아질까요? 그렇습니다 — 전립선 수술 후 요실금은 특히 골반저근 운동을 꾸준히 하면 첫 6~12개월 동안 대부분 호전됩니다. 약 1년이 지나도 불편한 요실금이 지속된다면, 남성 슬링, 조절형 풍선, 또는 인공 요도괄약근을 고려할 시점입니다 — 이 방법들은 매우 효과적입니다.

진단 방법

- 언제, 얼마나 새는지 상담 (보통 **하루 패드 수**로 기록)
- **소변 검사**와 방광 배뇨 확인
- 수술 전: 요도경 검사(방광경 검사)와 경우에 따라 요역동학 검사

치료 방법 (단계별)

- 1 **골반저근 운동**(케겔), 이상적으로는 수술 즈음부터 시작하며, 수분 조절과 체중 관리를 병행합니다.
- 2 첫 1년간 **경과 관찰**하며 필요 시 패드나 보호 용품을 사용합니다.
- 3 **남성 슬링** — 지속적인 경증~중등도 요실금에 사용합니다.
- 4 **ProACT 조절형 풍선** — 경증~중등도 요실금의 또 다른 최소침습 선택지로, 외래에서 여러 번 조정합니다(방사선 치료 후에는 사용 불가).
- 5 **인공 요도괄약근(AUS)** — 중등도~중증 요실금의 표준 치료법이며, 방사선 치료 후에도 선택할 수 있습니다. 각각의 별도 안내문이 있습니다.

남성 복합성 요실금과 생활 관리

- 골반저근 운동을 꾸준히 하세요 — 가장 기본이 됩니다.
- 회복 중 자신감을 위해 패드나 보호 속옷을 사용하세요.
- 야간 요실금이 문제라면 저녁 수분과 카페인을 줄이세요.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 따끔거림, 발열, 또는 **혈뇨** (감염 가능성)
- 갑자기 **소변을 볼 수 없는** 경우
- 요실금이 나아지지 않고 오히려 심해지는 경우

기억할 세 가지

1. 남성 복합성 요실금은 거의 대부분 전립선 수술이나 방사선 치료 후 괄약근이 약해져서 발생하며, 첫 1년간 대부분 호전됩니다.
2. 골반저근 운동이 기본이며, 지속되는 요실금에는 남성 슬링이나 인공 요도괄약근이 매우 효과적입니다.
3. 수술 결정 전 최대 1년을 기다리세요. 발열, 혈뇨, 또는 소변을 볼 수 없을 때는 의료진에게 연락하세요.